

Psychotropes et dysurie (difficultés à uriner)

💊 De nombreux psychotropes peuvent induire ou aggraver une dysurie (difficultés à uriner). Cet effet indésirable n'est pas toujours spontanément mentionné par les usagers, qui n'osent pas en parler ou ne font pas le lien avec le traitement. Il est donc important que les professionnels de santé pensent à le rechercher.

💧 Le plus souvent, il s'agit de difficultés chroniques :

- 💡 difficultés à commencer à uriner
- 💡 jet urinaire faible, difficile à contrôler
- 💡 poussées abdominales nécessaires
- 💡 sensation d'avoir toujours besoin d'uriner, besoin urgent d'uriner
- 💡 nombreux éveils nocturnes pour uriner

💧 Parfois, il s'agit d'une impossibilité totale à uriner de survenue brutale :

- 💡 la rétention aigüe des urines dans la vessie ("globe vésical") est très douloureuse
- 💡 elle demande une prise en charge rapide
- 💡 chez les personnes ayant des difficultés de communication, y penser en cas d'apparition inexpliquée d'une agitation ou d'un syndrome confusionnel

💧 De nombreux autres facteurs augmentent le risque de dysurie

- 💡 personne âgée
- 💡 sexe masculin
- 💡 pathologies de la prostate
- 💡 pathologies du système nerveux périphérique
- 💡 diabète, etc.

💊 Les effets anticholinergiques (ou atropiniques) des psychotropes sont le plus souvent impliqués dans l'apparition d'une dysurie, en diminuant le tonus et la mobilité des muscles lisses.

💊 Cet effet anticholinergique est recherché quand on prescrit des « correcteurs » antiparkinsoniens pour diminuer les effets extra-pyramidaux (moteurs) des antipsychotiques.

💊 En revanche, les effets anticholinergiques sont indésirables pour de nombreux autres psychotropes :

- 💡 antipsychotiques : la majorité des 1^{ère} génération (lévoméproméazine, cyamémazine, loxapine, chlorpromazine, etc.) et certains de 2^{nde} génération (surtout clozapine, mais aussi olanzapine et quétiapine)
- 💡 antidépresseurs : surtout les tricycliques et la paroxétine
- 💡 anxiolytiques: surtout hydroxyzine et alimémazine

💊 Plus rarement, l'apparition d'une dysurie est liée à l'augmentation de l'activité

- 💡 sérotoninergique (antidépresseurs ISRS)
- 💡 noradrénergique (antidépresseurs IRSNa)

🎯 Réduire la polythérapie ("mille-feuille") de psychotropes est la meilleure stratégie pour prévenir une dysurie. Diminuer la charge anticholinergique cumulée permet aussi de limiter le risque de constipation sévère, de sécheresse buccale, de troubles de la vision, etc.

- 💡 arrêter les "correcteurs" quand ils ne sont plus nécessaires, comme après un relais par clozapine
- 💡 limiter les prescriptions d'antipsychotiques sédatifs, dont le rapport bénéfice/risque est défavorable

⚠ sans oublier les traitements anticholinergiques prescrits par d'autres collègues ou pris en automédication !

Références

<https://doi.org/10.2165/00002018-200831050-00002>

<https://doi.org/10.1007/s40801-024-00465-8>

